

SILVIO DA COSTA

HD:

MEDICO:

Dr. Raimundo Panarelli

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

IAH = 69,8

OXIMETRIA:

15/01

Foi realizado PSG, pressão definida 5.
PSG 1 CPAP: IAH = 60,8

Adquirir CPAP Bliti 7 max. Dream wisp.

20/01

ajustei a máscara e reentei - Jua

27/01

P = 5cmH₂O

IAH = 3,1

m. de uso: 7h Jua

15/06

18/08

P = 5

IAH = 10,8

m. de uso: 7h20' Jua

19/10

P = 6cmH₂O

IAH = 1,5

m. de uso: 8h Jua

20/12

P = 6cmH₂O

IAH = 1,3

m. de uso: 7h Jua

07/03

P = 6cmH₂O

IAH = 1,3/2

m. de uso: 7h15' Jua

06/05

P = 6cmH₂O

IAH = 1,5

m. de uso: 7h33 Jua

05/07

P = 6cmH₂O

IAH = 2,0

m. de uso: 7h48 Bem adaptado Jua

04/10

P = 6cmH₂O

IAH = 1,9/2

m. de uso: 7h10', Bem adaptado Jua

06/12
22 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 2.1 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 14'
Fuga = 11.2 e/min.

Justa.

07
02 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 2.3 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h
Fuga = 8.6 e/min

Bem adapt. — Justa

05/09
23 $P = 6.0$
 $\text{IAH} = 0.7 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 30'

Justa

06/06
23 $P = 6.0$
 $\text{IAH} = 2.5 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 23'
Bem adaptado

$\left\{ \begin{array}{l} \uparrow 4.6 \text{ início} \\ \uparrow 6.6 \text{ final} \end{array} \right.$

— Justa.

05/09
23 $P = 6.0$
 $\text{IAH} = 2.8 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 15'
Bem adapt.

(100%) de uso.

Justa.

05/12/23 $P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.3 \text{ e/h}$
fuga = 14 e/min
m. de uso = 6h 50 min

06/02
24 $P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.4 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h
Fuga = 7h.

Relata de a masc. quebrou
esta quando a D. wear
Filtro OK
Justa.

30/04
24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.5 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 13 m
fuga: 0.1 e/m (mediana)

Bem adaptado
Natacha

23/07/24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.8 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h 12'
fuga: 13.6 e/m

Bem adaptado
Natacha

23/10/2024

$P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 1.5$
m. de uso: 7h 15'
fuga: 10 e/min
Sua

Flávio Augusto Passarelli Prado
ORINOLARINGOLOGIA

100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Tutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Silvio da Costa

Solicito adaptação de CPAP a pressão sugerida de
5cmH2O

G47.3

DR. FLÁVIO A. P. PRADO
Otorrinolaringologista
CRM 140.711

Rua Heitor Villa Lobos, 1450.

São José dos Campos - SP

CEP 12245-280 Tel.(12) 3922-6793 - 3922-5881

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Silvio da Costa

EXAME nº: 4638

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 13/03/2020

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h17min e concluído às 06h13min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 75 minutos. O tempo total de sono foi de 442,5 minutos (07h22min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 92,9%. A distribuição do sono mostrou 6,8% de estágio 1, 41,7% de estágio 2, 24,9% de estágio 3 e 26,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 28 minutos em vigília, ocorreram 65 microdespertares (índice: 8,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 60,8/hora, sendo 28,1 apneia/hora e 32,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 60,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (60,8/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (60,8/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 63 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (75 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (92,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (8,8/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (24,9%; normal: 10-12%) e REM (26,7%; normal: 20%), e a redução dos estágios 1 (6,8%; normal: 8-10%) e 2 (41,7%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Nome: SILVIO DA COSTA
Data de Nascimento: 31-3-1960
IMC: 25,82
Sexo: Masculino
Data do exame: 14-12-2020

Peso: 72 kg
Altura: 1,67 m
Médico: DR. FLAVIO A. PASSARELLI
PRADO
Medicamentos: 0
Histórico: APNEIA/TITULAÇÃO DE CPAP

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 14-12-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 456,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 33,0 e 199,5 minutos. O tempo total de sono foi de 456,5, eficiência de 66,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,5%; estágio N2: 58,3%; estágio N3: 19,0%; sono REM: 18,2%. O índice de despertares foi de 4,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 4,8/hora, sendo elas 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 22 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 87%, permanecendo 0,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 77 bpm e NREM de 43 - 84 bpm.

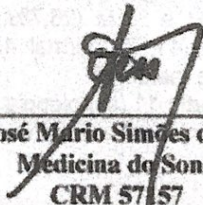
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco leve durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

10/125 P=6 cmH₂O
IAH=1,6 e/h
m. de uso: 6 h 44'
fuga: Ø

Bem adaptado
S/ queixas

16/04/2015 P=6 cmH₂O
IAH=1,4 e/h
m. de uso: 7 horas
fuga: 13 l/min

Natacha

Bem adaptado s/ queixas
siente higienizap.

16/07/25 P=6 cmH₂O
IAH=1,5 e/h
m. de uso: 7 h 5'
fuga = 10,2 lpm.

- Relato estar bem, sem queixas.
- mantendo horário de dormir e acordar.
fuo.